

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

Maxflúor 2 mg/ml solução bucal

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

MAXFLÚOR, solução bucal a 2‰

Fluoreto de sódio.....2 g

Excipientes com efeito conhecido :

Amarante (E123), 1 µl/ml

Ácido benzóico (E210), 0,5 mg/ml

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Solução bucal.

Líquido límpido e fluido de cor rosácea, com sabor acidulado e ligeiramente mentolado.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas:

Profilaxia da cárie dentária.

4.2 Posologia e modo de administração

O Fluoreto de Sódio pode ser administrado como um suplemento oral. A dose diária deve ser ajustada de acordo com o conteúdo de flúor da água de consumo, com o flúor ingerido a partir de outras fontes, como a dieta ou as pastas dentífricas e de acordo com a idade da criança. Após a erupção dos dentes, as aplicações locais são eficazes.

As posologias apresentadas na tabela seguinte apresentam um ajustamento ao teor local da água de consumo:

Concentração de fluoreto na água de consumo (mg/L)	< 0,3	0,3 – 0,7	> 0,7
Idade	Posologia recomendada (mg F/dia)		
2 semanas aos 2 anos	0,25	0	0
2 anos aos 4 anos	0,50	0,25	0
4 anos 16 anos	1,00	0,50	0

Salvo indicação contrária do médico a posologia diária recomendada é a seguinte:

Solução de fluoreto de sódio a 2% ou 0,2%:

Podem ser utilizadas lavagens da boca diárias com Fluoreto de Sódio a 0,05%:

- retirar 2,5ml da solução a 0,2% e completar com água para 10ml;

ou lavagens semanais a mensais, com Fluoreto de Sódio a 0,2%:

- utilizar 10ml da solução a 0,2%.

Estas lavagens não são recomendadas para crianças com idade inferior a 6 anos.

Modo de Administração: Bochechar durante 1 minuto após a lavagem dos dentes.

NÃO ENGOLIR. Recomenda-se não comer, beber ou lavar a boca durante 15 minutos após a utilização.

O Maxflúor deve ser administrado continua e regularmente desde o período de formação dos dentes (estado latente) até cerca dos 15 anos. Posteriormente, a administração de suplementos de flúor é normalmente conduzida através de soluções orais.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos componentes.

A utilização de soluções ou geles de fluoreto de sódio em crianças com menos de 6 anos de idade não está recomendada devido ao risco de ingestão destes produtos.

O excesso de fluoretos, em crianças ou adultos, pode levar à fluorose dental e modificações ósseas.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Ingestões prolongadas de doses elevadas de fluoretos podem conduzir a fluorose dentária. No entanto, dentro dos regimes posológicos recomendados, nunca se verificaram casos de toxicidade aguda.

Nas áreas onde existem teores significativos de flúor nas águas de consumo, a dosagem de Maxflúor deve ser reduzida. Se a água contém mais de 0,7 mg de flúor por litro, o suplemento não está recomendado.

Pacientes com insuficiência renal poderão ser suscetíveis a fluorose. Deverá utilizar-se com precaução em casos de insuficiência renal grave, úlceras gastroduodenais e artralgias uma vez que estas situações poderão ser exacerbadas.

A administração da solução bucal em crianças deve ser efetuada por um profissional, com a criança inclinada para a frente, para evitar qualquer deglutição accidental.

Idosos

Não foram reportados problemas em pacientes idosos nas doses normais recomendadas. Os pacientes idosos têm maior probabilidade de dores nas articulações, problemas renais ou úlceras gastrointestinais que se agravam com doses elevadas.

População pediátrica:

Não foram reportados problemas em crianças com a dose diária recomendada. Doses de fluoreto de sódio superiores ou tomadas durante um período mais alargado podem causar problemas ósseos ou coloração dos dentes.

Insuficientes renais

Pacientes com problemas renais têm de ter uma posologia adaptada (inferior ao normal) uma vez que correm o risco de acumulação de fluoretos o que conduz a situações de fluorose com riscos de fraturas, entre outros.

Insuficientes hepáticos

Não existe informação sobre a necessidade da adaptação da posologia em pacientes com problemas hepáticos.

Maxflúor, solução bucal

Contém Amaranthina (E123). Pode causar reações alérgicas.

Contém Ácido benzóico (E210). Ligeiramente irritante para a pele, olhos e mucosas.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

A toma de fluoreto de sódio juntamente com antiácidos contendo alumínio e/ou juntamente com cálcio, magnésio ou outros iões, e sais de ferro leva a uma diminuição na absorção do fluoreto de sódio devido à formação de complexos insolúveis.

A ingestão de fluoreto de sódio com produtos lácteos leva a um atraso na absorção e a uma diminuição dos picos séricos devido à formação de um ião pouco absorvível de fluoreto de cálcio.

Interferência dos meios complementares de diagnóstico

As concentrações séricas do aspartato de aminotransferase e fosfatase ácida podem estar falsamente elevadas.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

A administração de fluoreto de sódio a grávidas, dos 3 aos 9 meses de gravidez, leva a uma prevenção segura e efetiva das cáries dentárias.

Amamentação

Estudos em mulheres sugerem que a ingestão de fluoretos apresenta um risco mínimo para o bebé durante a amamentação.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos de Maxflúor sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

4.8 Efeitos indesejáveis

Os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de frequência.

As frequências são definidas segundo a seguinte convenção: muito frequentes ($\geq 1/10$), frequentes ($\geq 1/100$, $<1/10$), pouco frequentes ($\geq 1/1000$, $<1/100$), raros ($\geq 1/10000$, $<1/1000$), muito raros ($<1/10000$), desconhecido (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).

Doenças do sistema nervoso

Pouco frequentes: Cefaleias

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos

Raros: rash cutâneo, urticária, dermatite esfoliativa, dermatite atópica, reações alérgicas gastrointestinais e respiratórias

Doenças gastrointestinais

Pouco frequentes: sangramento gastrointestinal, náuseas, vômitos, anorexia, diarreia, fluorose dentária

Raros: estomatite

Afeções musculoesqueléticas e dos tecidos conjuntivos

Raros: sinovite, fascite plantar

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

4.9 Sobredosagem

Sobredosagem crónica:

A sobredosagem crónica pode conduzir a fluorose esquelética, osteomalacia e a osteosclerose.

A manifestação principal de ingestão crónica excessiva de flúor, por exemplo 2mg de flúor por dia durante os anos necessários para calcificação do esmalte dos dentes, é o esmalte mosqueado nos dentes erupcionados

Sobredosagem aguda:

Ingestões prolongadas de doses elevadas de fluoretos podem conduzir a fluorose dentária. No entanto, dentro dos regimes posológicos recomendados, nunca se verificaram casos de toxicidade aguda.

Níveis sanguíneos de fluoretos de 190 ng/ ml foram associados a efeitos secundários reumatológicos.

Os sintomas incluem: hipersalivação, sabor anormal, tremores, fraqueza, convulsões, tetania, respiração superficial, insuficiência respiratória, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal difusa, hipocalcemia, distúrbios hidroelectrolíticos, disritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e choque.

Os tratamentos incluem lavagem gástrica (solução de hidróxido de cálcio a 0,15%) para limitar a absorção do flúor, fluidoterapia, administração de leite ou cálcio (sob a forma de gluconato a 10%, por via intravenosa), tratamento sintomático e eventualmente hemodiálise.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo fármaco-terapêutico: 11.3.2.2 Nutrição. Nutrição entérica. Vitaminas e sais minerais. Sais minerais. Flúor

6.1.1 Aparelho digestivo. Medicamentos que atuam na boca e orofaringe. De aplicação tópica
Classificação ATC: A12C D01

Os fluoretos são largamente usados na proteção contra as cáries dentárias. Para obter uma proteção substancial, a administração de flúor deve ser contínua e consistente desde o período de desenvolvimento e calcificação dos dentes, mantendo-se por largos períodos mesmo após a erupção daqueles.

A ação dos iões fluoreto deve-se sobretudo à incorporação do flúor na estrutura do esmalte dentário, o que ocorre durante a formação dos dentes e após a erupção, pela acumulação deste elemento nas camadas externas do esmalte.

Por outro lado, o enriquecimento do esmalte em flúor é aumentado quando se administra conjuntamente soluções orais de fluoreto de sódio que promovem benefícios adicionais no combate à cárie em crianças com idades iguais ou superiores a 5 anos.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Absorção:

O fluoreto de sódio é rápida e praticamente todo absorvido no trato gastrointestinal. Uma porção substancial de fluoreto de sódio, administrado oralmente, é absorvido no estômago, sendo a velocidade de absorção dependente do pH gástrico.

Distribuição:

Após absorção, os fluoretos são armazenados nos ossos e nos dentes em desenvolvimento. O tecido ósseo possui uma elevada capacidade de armazenar fluoretos e possui um mecanismo mobilizador que mantém os níveis corporais de fluoretos, mecanismo este que é importante para a cedência de fluoretos para os dentes em desenvolvimento.

Aproximadamente 99% dos fluoretos totais corporais são fortemente ligados aos tecidos calcificados, sendo essa ligação reversível.

Eliminação:

Os fluoretos são rapidamente eliminados na urina; uma pequena porção é eliminada nas fezes. Aproximadamente 90% dos fluoretos são filtrados no glomérulo renal e são reabsorvidos a vários níveis do túbulo renal.

A depuração renal em adultos é de aproximadamente 30 a 40 ml/minuto.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

O fluoreto de sódio induziu aberrações cromossómicas em testes in vitro, mas não in vivo, o que poderá estar relacionado com diferentes níveis de concentração. Não foi mutagénico em testes com bactérias.

O fluoreto de sódio não foi carcinogénico, em estudos realizados em ratinhos e ratos, nem demonstrou potencial teratogénico. Efeitos embrio-fetotóxicos foram observados unicamente em doses elevadas.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Solução de Amarante (E123);
Solução de Ácido Benzoico (E210);
Óleo essencial de hortelã-pimenta;
Água purificada.

6.2 Incompatibilidades:

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade:

A solução bucal de MAXFLÚOR de 2‰ mantém-se estável durante 5 anos.

Após abertura: 90 dias.

6.4 Precauções especiais de conservação

Não conservar acima de 25°C.

Condições de conservação do medicamento após primeira abertura, ver secção 6.3.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente:

Frascos de 100 ml e 1000 ml de solução bucal a 2‰.

O Maxflúor Solução bucal apresenta-se em frascos de polietileno de 100 ml ou 1000 ml e fechado por uma tampa de polipropileno (1000 ml) ou polietileno (100 ml).

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

A solução bucal deve ser bochechada durante 1 minuto após a lavagem dos dentes. Não engolir. Recomenda-se não comer, beber ou lavar a boca durante 15 minutos após a utilização.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

LABESFAL - Laboratórios Almiro, S.A.
Zona Industrial do Lagedo
3465-157 Santiago de Besteiros - Portugal

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

MAXFLÚOR:

- Solução bucal a 2 ‰ - embalagem de 100 ml de solução: 2083095
- Solução bucal a 2 ‰ - embalagem de 1000 ml de solução: 2083194

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

MAXFLÚOR solução bucal a 2 ‰ de fluoreto de sódio: 23-04-1994.

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO